SANATORIO ARGENTINO

DIRECCIÓN MÉDICA Y GERENCIA DE OPERACIONES · CONTACT CENTER

AUDITORÍA DE CONVERSACIONES, CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA

ANÁLISIS DE CONVERSACIONES TOTALES VS. CAPACIDAD MÁXIMA OPERATIVA

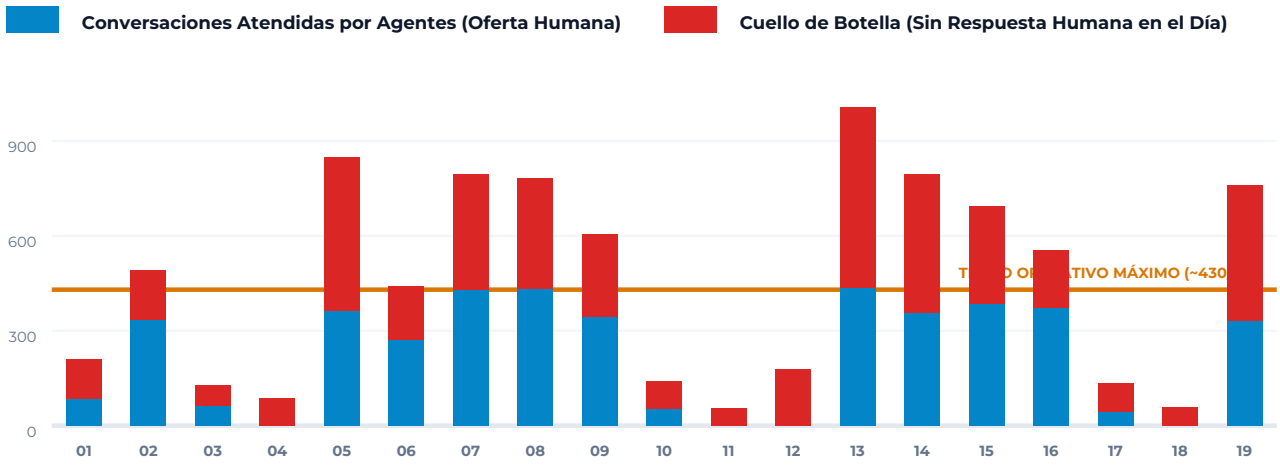
Período de Auditoría: 01 al 19 de Octubre de 2026 (19 jornadas) | Sesiones Totales: 8.765 conversaciones

CONVERSACIONES TOTALES	ATENDIDAS POR AGENTES	CUELLO DE BOTELLA	TECHO MÁXIMO OPERATIVO
8.765	**4.306**	**4.459**	**~430 conv/d**
En 5.589 pacientes únicos	Capacidad humana (49%)	Sin respuesta de agente (51%)	Máximo histórico del equipo

DIAGNÓSTICO CRÍTICO: TRABAJO SISTEMÁTICO POR ENCIMA DE LA CAPACIDAD MÁXIMA

Al computar las conversaciones día a día (considerando que un paciente que escribe en días distintos equivale a conversaciones independientes), se registran 8.765 sesiones de atención en 19 días (+61% respecto al padrón estático de teléfonos). El equipo de operadoras posee un techo operativo estricto de ~430 conversaciones/día. En días hábiles pico, la demanda de los pacientes alcanza entre 780 y 1.006 conversaciones diarias, generando una sobredemanda de hasta un 130% por encima de la capacidad instalada. Como consecuencia directa, 4.459 conversaciones (51% del total) no pudieron recibir respuesta humana en el día, dependiendo exclusivamente de la contención del Bot o quedando en espera prolongada.

GRÁFICO 1: CONVERSACIONES DE PACIENTES VS. CAPACIDAD ATENDIDA POR AGENTES (DÍA A DÍA)

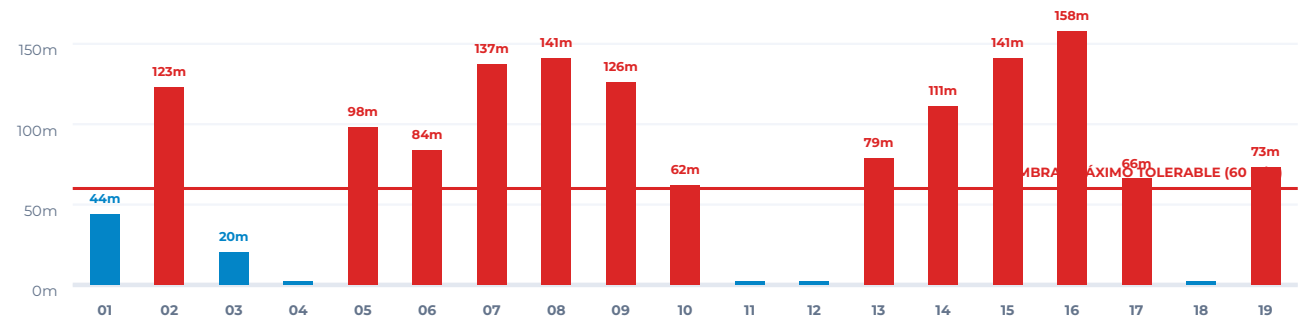


Las barras rojas representan pacientes que escribieron pero la dotación de operadoras no dio abasto para responderles en el día.

EL CUELLO DE BOTELLA OPERATIVO Y EL RETRASO EN LA ATENCIÓN

Cuando la cantidad de pacientes que escriben desborda la capacidad de las operadoras, se generan dos efectos adversos inmediatos: 1) El tiempo de espera hasta la primera respuesta humana se dispara a valores críticos de entre 98 y 141 minutos (más de 2 horas de demora media en días hábiles); y 2) Pacientes que no reciben atención en el día reingresan al día siguiente, incrementando aún más la cola de mensajes acumulados.

GRÁFICO 2: TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA RESPUESTA HUMANA (MINUTOS)



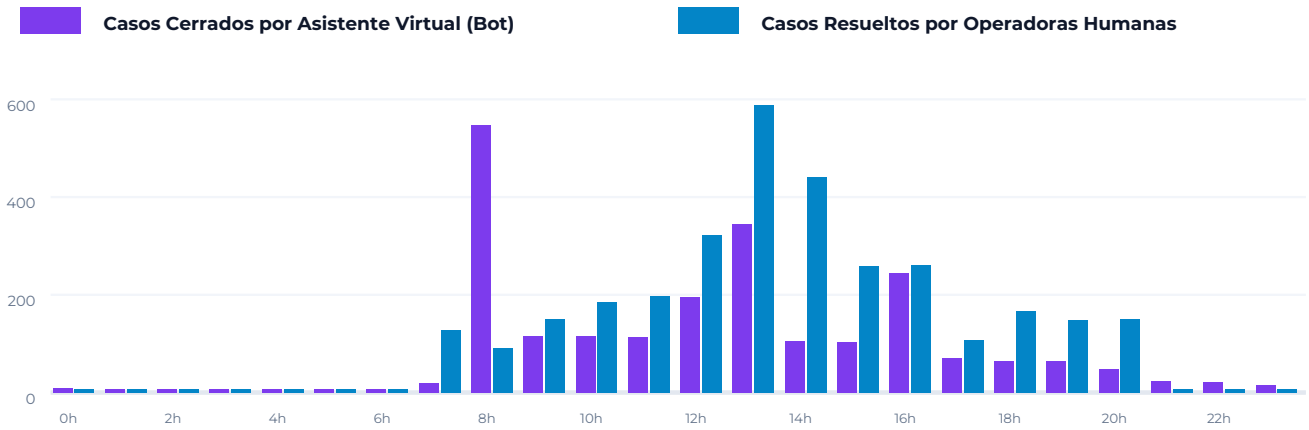
DÍAS DE MÁXIMO COLAPSO Y DÉFICIT DE CAPACIDAD OPERATIVA

Jornada Crítica	Conversaciones Pacientes	Atendidas por Operadora	Sin Respuesta Humana	Espera Media	Impacto Operativo Registrado
Mar 13/10 (Post-Feriado)	**1.006 convs**	436 convs (43%)	**570 convs (57%)**	**79 min**	Déficit del 131% sobre el techo humano. 570 pacientes sin respuesta de operadora.
Lun 05/10 (Inicio Semana)	**847 convs**	362 convs (43%)	**485 convs (57%)**	**98 min**	Sobredemanda masiva. El 57% de los pacientes solo interactuó con el Bot.
Mié 07/10 (Pico Laboral)	**796 convs**	431 convs (54%)	**365 convs (46%)**	**137 min**	El tiempo de espera alcanzó 2 horas y 17 minutos promedio para ser atendido.
Jue 08/10 (Demora Máxima)	**781 convs**	433 convs (55%)	**348 convs (45%)**	**141 min**	Retraso de 2 horas y 21 minutos. Se acumuló cola residual de la jornada anterior.
Mié 14/10 (Segundo Tramo)	**796 convs**	359 convs (45%)	**437 convs (55%)**	**111 min**	Más de la mitad de los pacientes sin intervención de operadora humana.

CÓMO Y CUÁNDO ACTÚA EL BOT FRENTE AL CUELLO DE BOTELLA

El asistente automatizado es el único amortiguador que previene el colapso absoluto del servicio. De los 3.958 pacientes que no recibieron respuesta humana, el Bot contuvo de forma autónoma al 97% de ellos (3.834 pacientes), brindándoles respuesta de horarios, requisitos, aranceles y derivaciones. Sin el Bot, estos pacientes habrían quedado en silencio absoluto.

GRÁFICO 3: RITMO HORARIO DE GESTIÓN Y CIERRES (00:00 A 23:00 HS)



El Asistente Virtual actúa intensivamente a las 08:00 hs (592 cierres) y 13:00 hs (338 cierres) por barridos automáticos nocturnos.

MODALIDADES EN QUE EL ASISTENTE VIRTUAL DESCONGESTIONA LA BANDEJA:

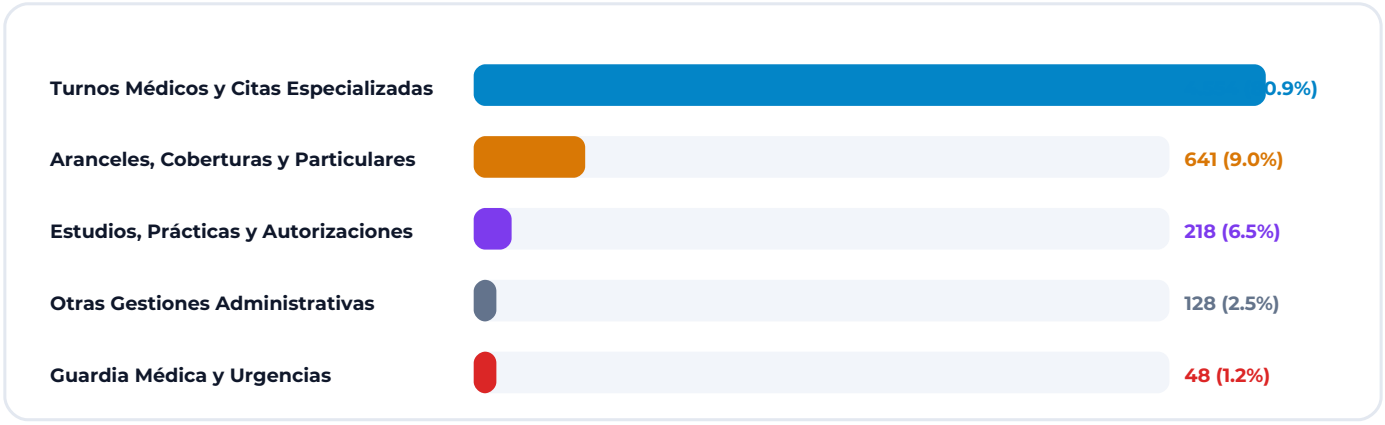
1. Barrido Nocturno Automático (+12h/+24h): A las 08:00 hs depura cientos de conversaciones iniciadas la noche anterior que ya recibieron respuesta automática del menú, evitando que ingresen como pendientes a las operadoras.

2. Auto-gestión de Información y Horarios: El 53% de las consultas cerradas por bot corresponden a pacientes que encontraron respuesta a su inquietud en el menú interactivo y no requirieron esperar a una asesora.

3. Confirmación de Citas Médicas Agendadas: El bot valida automáticamente citas ya coordinadas sin consumir tiempo operativo del personal presencial.

¿QUÉ CONSULTAN LOS PACIENTES? ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL

Para resolver de raíz el cuello de botella, es imperativo entender qué motiva a los pacientes a escribir. El análisis clasificado demuestra que más de 8 de cada 10 consultas (80.9%) corresponden a solicitudes de Turnos Médicos con especialistas, seguidas por dudas sobre Aranceles Particulares / Coberturas (9.0%) y Autorizaciones de Estudios (6.5%).



IMPACTO ASISTENCIAL DE CADA MOTIVO EN EL CUELLO DE BOTELLA

Motivo Principal	Volumen	Impacto en la Carga de Trabajo de las Operadoras
Turnos Médicos (80.9%)	**3.935**	Es el generador del 80% de la congestión. Las pacientes demandan turnos con profesionales específicos y requieren múltiples intercambios de mensajes para coordinar fecha y horario.
Aranceles y Particulares (9.0%)	**440**	Consultas por costo de consulta particular sin obra social. El bot ya informa aranceles orientativos y deriva a recepción presencial, reduciendo consultas repetitivas.
Estudios y Prácticas (6.5%)	**315**	Validación de órdenes para ecografías, laboratorios y radiografías. Consume tiempo de operadora por la necesidad de inspeccionar fotos adjuntas.
Guardia y Urgencias (1.2%)	**56**	Casos con sintomatología aguda. El triaje automatizado los detecta de inmediato y los instruye a presentarse en la Guardia de Emergencias.
Otras Gestiones (2.5%)	**120**	Retiro de estudios, contacto institucional y consultas varias.

MATRIZ DE CONVERSACIONES, ATENCIÓN Y CUELLOS DE BOTELLA (DÍA A DÍA)

Fecha	Convs Pacientes	Atendidas Agente	Sin Resp. Humana	% Sin Agente	Espera Media	Msgs Entrantes	Msgs Agentes	Msgs Bot
2026-10-01	210	86	124	59%	44 min	503	414	224
2026-10-02	490	334	156	32%	123 min	2.457	1.572	1.537
2026-10-03	128	64	64	50%	20 min	696	332	392
2026-10-04	88	0	88	100%	-	323	0	300
2026-10-05	847	362	485	57%	98 min	4.698	1.496	3.052
2026-10-06	440	270	170	39%	84 min	2.537	1.227	1.388
2026-10-07	796	431	365	46%	137 min	4.511	2.051	2.887
2026-10-08	781	433	348	45%	141 min	4.166	1.843	2.713
2026-10-09	605	344	261	43%	126 min	2.966	1.666	1.553
2026-10-10	141	53	88	62%	62 min	579	230	383
2026-10-11	54	0	54	100%	-	162	0	145
2026-10-12	179	0	179	100%	-	648	0	569
2026-10-13	1.006	436	570	57%	79 min	4.919	2.002	3.209
2026-10-14	796	359	437	55%	111 min	3.761	1.608	2.372
2026-10-15	694	387	307	44%	141 min	3.564	1.637	2.333
2026-10-16	555	373	182	33%	158 min	2.961	1.584	1.819
2026-10-17	134	43	91	68%	66 min	506	224	375
2026-10-18	60	0	60	100%	-	169	0	159
2026-10-19	761	331	430	57%	73 min	3.910	1.436	2.611
TOTALES	**8.765**	**4.306**	**4.459**	**51%**	**108 min prom**	**44.036**	**19.322**	**28.021**

PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO PARA ELIMINAR EL CUELLO DE BOTELLA:

1. Autogestión Autónoma de Turnos (El 81% de la demanda): La única vía para no desbordar la capacidad humana es permitir que el paciente consulte y confirme turnos médicos directamente con el asistente virtual en los profesionales con agenda abierta, reservando la operadora solo para casos complejos. 2. Refuerzo en Franjas Críticas (Lunes y Martes 08:30 a 14:00 hs): Concentrar dotación y guardias en las mañanas de inicio de semana, donde se acumulan más de 500 pacientes sin atender. 3. Notificaciones Proactivas de Demora: Informar al paciente su posición y tiempo estimado de espera para evitar reingresos reiterados que saturan la bandeja.

SUPERVISIÓN GENERAL DE CONTACT CENTER
Sanatorio Argentino · San Juan

DIRECCIÓN MÉDICA Y CALIDAD OPERATIVA
Sanatorio Argentino · Gestión 2026